BANQUE NATIONALE ECOS
Fiche signalétique Station ECOS

Identifiant de la station *(réservé à l'organisateur)*	Station XXX
Spécialité	ORL
Grand système	Cavité Nasale
Lieu de soins (Urgences, Cabinet, autre à préciser)	Urgences
Situation de départ (N° et intitulé)	SDD-147 Epistaxis
Attendu(s) d'apprentissage (selon la fiche SDD)	Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnostiques - familles Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires - familles Echanger avec les différents intervenants (soignants - médecins) pour la réalisation des explorations diagnostiques et thérapeutiques - familles Informer et expliquer la situation aux responsables légaux et à l'enfant avec un discours adapté - familles Produire une attitude relationnelle empathique et rassurante - familles
Item(s) de connaissance	87 : Epistaxis 298 : Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives supérieures
Participant standardisé : *homme / femme / indifférent (aidant, parent, professionnel de santé standardisé.. / NA*	Adolescent de sexe masculin
Catégorie d'âge *Enfant/nourrisson représenté par …parent, aidant…/ adulte / > 65 ans/indifférent/ NA*	
Auteur(s)	MILTENBERGER Marie
Faculté (UFR) des auteurs	NICE
Date de création	01/11/2023

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

- Diagnostiquer une épistaxis et la quantifier
- Chercher les signes d'interrogatoire et d'examen clinique en facteur d'une cause infectieuse, tumorale, inflammatoire, traumatique ou essentielle
- Déterminer la prise en charge d'un épistaxis abondant

Participant Standardisé

Homme de 16 ans

Matériel nécessaire à la station

● Aucun matériel nécessaire

Consignes à l'intention de l'examinateur : ECOS formatif/ évaluatif

L'étudiant doit être capable de :

- Identifier/reconnaitre une épistaxis
- Rechercher les différentes étiologies d'épistaxis
- Expliquer la stratégie thérapeutique d'une épistaxis sévère

Instructions au participant standardisé

Consignes générales & Rappel :

En dehors de la phrase de démarrage, aucune information ne doit être révélée si l'étudiant n'a pas spécifiquement posé la question. ***Si c'est nécessaire pour le scénario, préciser en gras des éléments qui peuvent être donnés spontanément par le PS.***

Lieu de soins : *Bureau médical dans le service des urgences*

Synopsis : *décrire ici en quelques phrases au patient le rôle qu'il ou elle va jouer.*

Vous êtes un patient dans le service des urgences. Vous venez à la suite d'un saignement nasal de forte abondance qui dure depuis quelques jours. Vous saignez fréquemment du nez mais n'étiez pas allé aux urgences jusqu'à présent car les saignements étaient moins abondants. Les saignements sont bilatéraux et visibles sur la paroi pharyngée postérieur. Vous n'avez pas subi de traumatisme

L'examinateur rappelle que l'étudiant a 7 minutes pour réaliser l'examen clinique, établir un diagnostic, rechercher les lésions associées et définir des critères de gravité ainsi que proposer la suite de la prise en charge.

IDENTITÉ

Mr FORET

Age : *16 ans*

Taille : 1m65 Poids : 54 kg

CONTEXTE SOCIOPROFESSIONNEL – LOISIRS

Habite dans une maison en ville avec ses parents

Profession : Lycéen

Pas de tabac, pas d'alcool

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

Opération de l'appendicite à l'âge de 10 ans.
Fracture du tibia à l'âge de 14 ans.

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

0

MÉDICAMENTS

0

Symptômes / Déroulement du scénario :

FC : 65 bats/min
FR : 14 mouvements/min
Evaluation douleur : 1/10 à l'arrivée

Observation IOA :
Patient se présente aujourd'hui par ses propres moyens après un saignement nasal abondant datant depuis 1 jour. Il vous précise que cela fait plusieurs fois qu'il saigne du nez mais jamais avec une telle abondance.
A l'arrivée, le patient comprime son nez avec des mouchoirs.

Traitements administrés :
Aucun
Observation Dr :
Etat général : Patiente cohérente, orientée.
Pas de tachycardie, pas d'hypotension orthostatique.

Examen clinique du poignet :
Examen clinique normal
Pas de signes de choc (cyanose, marbrure, pâleur, sueur)
Pas de télangiectasies

Inspection : Pas d'ouverture cutanée au niveau du visage.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes externe dans le service d'urgences à Pasteur 2. Votre interne vous demande d'aller voir un patient qui vient d'arriver. Ce patient, Mr FORET, vient pour saignement nasal.

Vous avez **8** minutes pour :

- Réaliser un examen clinique du patient.

- Proposer une mesure de prise en charge adapté

- Proposer la suite de la prise en charge en indiquant les différentes étiologies

Les grilles à imprimer pour l'examinateur :

Grille d'observation « Aptitudes cliniques » (10 à 15 éléments)

Aptitudes cliniques	Observé =1 Non observé = 0
TACHE 1	
Énonce « épistaxis »	
Quantifie l'épistaxis (abondance et durée)	
Chercher les facteurs généraux ou médicamenteux favorisant ou aggravant l'épistaxis (âge élevé, insuffisance coronarienne, troubles de l'hémostase, maladie de Rendu Osler, tumeur nasale, tachycardie, hypotension orthostatique, AEG, Signes de choc)	
Chercher les signes d'interrogatoire et d'examen clinique en facteur d'une cause infectieuse (fièvre, rhino sinusite récente), tumorale (obstruction nasale chronique, déficit des nerfs crâniens otite séreuse, adénopathies), traumatique (corps nasal étranger, intubation nasale récente)	
Déterminer les constantes du patient pour éliminer une HTA	
TACHE 2	
Expliquer la prise en charge initiale : évacuations caillots grâce à un lavage nasal et compression bi digitale pendant	
Expliquer que si le saignement persiste, il faudra un tampon hémostatique non résorbable puis un tamponnement antérieur avec du matériel résorbable.	

Banque d'échelles d'évaluation « communication attitudes »

Merci de sélectionner 2 à 5 éléments d'échelles par station en effaçant les autres

1. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante	Performance Limite	Performance Satisfaisante	Performance Très Satisfaisante	Performance Remarquable
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise de différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant le plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

2. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante	Performance Limite	Performance Satisfaisante	Performance Très Satisfaisante	Performance Remarquable
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

Échelle d'évaluation de la performance globale

Pour attribuer à l'étudiant une appréciation selon les 5 niveaux de performance , l'étudiant doit remplir la majorité des éléments qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Performance insuffisante	Performance limite	Performance satisfaisante	Performance très satisfaisante	Performance remarquable
Ne cite pas la notion d'épistaxis et ne propose pas de compression bi-digitale	Cite la notion d'épistaxis mais ne propose pas de prise en charge thérapeutique	Cite la notion d'épistaxis et propose une prise en charge comportant au moins une compression bi-digitale	Cite la notion d'épistaxis, de compression bi digitale et recherche une HTA, des signes traumatiques	L'étudiant a cité toutes les notions nécessaires lors de l'examen et à proposer une stratégie thérapeutique adéquate
• Pose des questions fermées • Approche désordonnée	• Entrevue peu structurée • Pose des questions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels Utilise de différents types de questions	Pose des questions précises couvrant le plupart des éléments avec quelques omissions mineures	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée Pose les questions avec assurance et savoir-faire

		couvrant les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée	